



FICHA ÚNICA DE ANAMNESIS – PSICOEDUKA

Instrucciones para la familia

Estimado/a tutor/a – apoderado/a – cuidador/a:

La siguiente anamnesis tiene como objetivo recopilar información relevante sobre la historia del niño/a, su desarrollo, contexto familiar, escolar y de salud, con el fin de iniciar un proceso de evaluación e intervención integral en Psicoeduka.

Por favor, responda con la mayor sinceridad posible, considerando que no existen respuestas correctas o incorrectas, sino información necesaria para comprender su realidad.

I. DATOS DE QUIEN RESPONDE

- Nombre completo: María de los Ángeles Moraga Morey y Felipe Andrés Harlowe Ventury.
- Relación con el niño/a: madre y padre.
- Teléfono principal: +56977787025
- Correo electrónico:
- Región / Comuna: Las Condes

Nombre del profesional que entrevista: Nicole Calderón Guzman T.O
Fecha de entrevista: 13-05-2026 y 9-06-2026

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO/A

- Nombre completo: Amelia Harlowe moraga
- RUT: 2658906465
- Fecha de nacimiento: 14 noviembre 2018
- Edad: 7 años.
- Sexo: ☐ Femenino ☐ Masculino ☐ Otro
- Previsión de salud: Cruz Blanca
- Dirección: Las condes, Pintor Somerscales 7993
- Región / Comuna: Las Condes

III. MOTIVO DE CONSULTA

1. ¿Cuál es el principal motivo por el que consulta en Psicoeduka?

El motivo es por indicación de la neuróloga, solicita trabajar la frustración y expresión de emociones debido a TDAH. 1. Vez 13 abril de este año

2. ¿Desde cuándo comenzaron las dificultades?

Frustración de pequeña, cuando se enojaba se iba hacia atrás y se pegaba en la cabeza cuando era bebe, después mordía a la mama cuando se enojaba, fue evolucionando.

Actualmente habla fuerte, llora y quiere estar sola. Se pone a llorar, siente que no puede respirar, se le dificulta volver a su estado emocional más estable.

Padre menciona “cuando algo no sale como ella quiere, por ejemplo ella puede tener un día muy lindo y le pasa algo malo y todo el día es malo”.

3. ¿A qué atribuyen ustedes estas dificultades?

A que es hija única y la “consienten”, la ayudan en lo que pueden. Padre menciona que es como una “princesita” que pide y recibe.

4. ¿Qué tratamientos, apoyos o intervenciones ha recibido anteriormente?

Asistió a la psicóloga por una evaluación, la neurologa deriva a sesiones de T.O.

IV. EXPECTATIVAS FAMILIARES

- ¿Cuáles son sus expectativas respecto del proceso de evaluación e intervención en Psicoeduka?

Buscan ayuda en como poner limite, hasta donde llegar para que ella también sea responsable de hacer sus cosas (hábitos diarios).

Que ella pueda expresar los sentimientos y emociones, reconocer errores y esforzarse en superarlos, realizar un trabajo sistemático y continuo es difícil para ella, no termina sus tareas.

Cambia de tema, quiere hacer otra cosa, necesita salir de la sala con frecuencia, se iba de la sala para ir al baño e iba a otro lado.

Le cuesta conectar con un grupo, muchas personas es difícil lidiar con eso a no ser que sea guiada por el adulto.

Le cuesta la comprensión de lo que lee, va a lo visual, según lo que ve el ejemplo. (Seguimiento de instrucciones e impulsividad)

No sale feliz del colegio, sale "taimada", padre comenta. Crearle la rutina es difícil, resistencia constante. Con lo que no le gusta hacer es inflexible.

V. ANTECEDENTES FAMILIARES

Composición familiar

- ¿Con quién vive actualmente el niño/a?

Con mamá y papá.

Madre / figura materna

- Nombre: María de los Ángeles Moraga Morey
- Edad: 37
- Ocupación: ejecutiva de banco
- Nivel educacional: universitario
- Relación con el niño/a: madre, buena, comparten su tiempo libre y de calidad.

Padre / figura paterna

- Nombre: Felipe Andrés Harlowe Venturino
 - Edad: 47
 - Ocupación: Trabajador en una empresa, responde madre de Amelia.
 - Nivel educacional: profesional completo, postgrado
 - Relación con el niño/a: muy buena. Super apegados.
-

VI. ANTECEDENTES PERINATALES

Embarazo

- ¿Cómo fue la reacción emocional ante el embarazo?

Muy buena

- ¿Fue un embarazo planificado? ☐ Sí ☐ No
- ¿Cómo fue la salud de la madre durante la gestación?

La madre dejo las pastillas y quedó embarazada. Debido a la enfermedad narcolepsia de la madre, fue un embarazo de “manual”, madre dormía mucho por no estar con tratamiento.

Parto

- Edad gestacional al nacimiento: A las 37 semanas
- Tipo de parto: normal.
- ¿Hubo complicaciones? ¿Cuáles?

Ninguna.

- Apgar: no recuerdan.
-

VII. ANTECEDENTES MÉDICOS Y DE SALUD

- Diagnósticos previos: madre narcolepsia, con tratamiento, padre con tdah. Rinitis.
 - Medicamentos actuales (nombre y dosis): nada, desloratadina por la alergia.
 - Alergias conocidas: madre comenta que podría ser algo con la lactosa porque se hincha, pero nunca le ha hecho exámenes, previenen con comida deslactosada.
 - Cirugías u hospitalizaciones: no
 - Enfermedades familiares relevantes (mentales o crónicas): padre TDAH, madre narcolepsia.
-

VIII. DESARROLLO PSICOMOTOR Y FUNCIONAL

Alimentación y lactancia

- Tipo de lactancia: ☐ **Materna** ☐ Artificial ☐ Mixta
 - ¿Cómo fue el proceso de alimentación y destete? Hasta 4 meses, banco de leche hasta 6 meses. Luego formula mezclada, al solo formula estaba adaptada debido a la transición mezclada.
-

Lenguaje y comunicación

- Edad inicio contacto ocular: todo bien.
- Edad inicio balbuceo: todo bien.
- Edad primera palabra: todo bien
- Edad primera frase: todo bien

No recuerdan fecha, pero comenta madre que nunca hubo una alerta por parte del pediatra.

- ¿Localiza sonidos? ☐ **Sí** ☐ No
- ¿Imita sonidos? ☐ **Sí** ☐ No
- ¿Interactúa con otros niños? Ejemplo:

Es hija única, cercana a su primo (Andres), interactúa más hombres y está mas acostumbrada a los juegos mas bruscos debido a que paso más tiempo con los primos hombres.

Con niños desconocidos, es super sociable, invita a niños a su casa. Le cuesta compartir (lo ve como una herramienta, ej para comenzar a sociabilizar con niños). Es empática con los demás niños (si se cae alguien lo ayuda).

Uso de pantallas

- ¿Ve pantallas? ☐ **Sí** ☐ No
- Tipo de contenido / tiempo / supervisión:

Video juegos, ahora no es tanto, máximo una hora diaria de lunes a viernes. Antes le hizo muy mal el uso de las pantallas en cuanto a lo que generaba en ella.

Motricidad – marcha

- Edad en que se sentó solo/a: sin problema
- Primeros pasos: al año y “algo”
- ¿Hubo accidentes? ☐ Sí ☐ **No**

- Reacción ante este cambio: le encantaba, buena reacción.
-

Sueño

- ¿Con quién durmió los primeros meses? Cuna colecho, nunca le gustó dormir acompañada.
 - ¿Presenta dificultades para dormir? Ninguna, algunos días le dan gotitas de melatonina cuando tiene mucha energía.
 - ¿Necesita rituales o compañía para dormir? Comida, ducha, leche, tuteo. Nunca se duerme sola, lo logra hacer, pero le gusta quedarse dormida acompañada.
-

Control de esfínter

- Edad de inicio: 2 años aproximadamente.
 - Forma en que lo aprendió: sin entrenamiento. Lo dejó en el día, luego en la noche. Tenía pelela por todos lados.
-

IX. ÁMBITO ESCOLAR

Jardín infantil / Sala cuna

- ¿Asistió? ☐ Sí ☐ No
- Edad de ingreso: 2022 Play Group
- Motivo de ingreso: para mayor estimulación y por que sus padres debían trabajar.
- Adaptación y relación con pares:

Asistió 2 días a sala cuna, se interrumpió por pandemia.

Muy buena la adaptación, hizo amigos en poco tiempo.

Escolaridad actual

- Nombre del establecimiento: Colegio San Nicolás de Myra.
 - Nivel / curso: 2 básico B
 - Jornada: ☐ Mañana ☐ Tarde ☐ Completa (martes a viernes 8.00 a 3:30, lunes 8 a 5:00)
- Asiste a gimnasia rítmica y también asiste a padel con sus primos).
- Horas diarias: _____
 - ¿Presenta adecuaciones curriculares? ☐ Sí ☐ No. Desde que le hicieron diagnóstico, la neuróloga entregó un informe con recomendaciones.

Trayectoria escolar

- Establecimientos anteriores y motivo de cambio: no.

-
- ¿Repitencias? ☐ Sí ☒ No

- Apoyos o intervenciones previas (PIE, tutorías, etc.): No, colegio si tiene PIE.

-
- Relación con docentes: buena, nunca ha tenido problemas, sabe con quien tiene más afinidad.

- Relación con pares: bien, pero es “delicada de cutis” menciona padre.

- Desempeño académico general: Padre comenta que hubo un mes que no le fue muy bien debido a que no revisaban cuadernos y se atrasaron con las tareas. Promedio 6.3 comenta padre.
-

X. REDES DE APOYO Y PROFESIONALES EXTERNOS

- Médicos o especialistas tratantes (nombre y especialidad):

Neuróloga tratante de la familia que derivo actualmente.

-
- Terapias actuales o previas:

Psicología (solo evaluación): sentía mucha pena o mucha rabia y ella se daba cuenta que no regulaba bien.

XI. REGULACIÓN, INTERESES Y OBSERVACIONES

- Juegos o elementos preferidos: -

- Actividades favoritas: pintar y bailar

- Cosas que lo/la tranquilizan: estar al aire libre, pasar el tiempo fuera de la casa, ir a la plaza, playa.

- Desencadenantes o sensibilidades: lavarse los dientes (repetición de instrucción que no sigue, padre cree que es por “llevar la contraria” madre dice que si es sensible al lavado de dientes) cepillarse el pelo Amelia dice que le molesta mucho, hace poco cortarse las uñas de las manos no

es un problema, con los pies presenta desafíos), a la temperatura igual (no le gusta leche fría) termina comiendo su comida fría.

- Otras observaciones relevantes:

Muchísimas gracias!